Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de Canela

Rua Dona Carlinda, 415 - Bairro: Centro - CEP: 95680000 - Fone: (54) 3282-1009 - Email: frcanelavjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001278-94.2022.8.21.0041/RS

AUTOR: LUCIANA TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA

AUTOR: JULIO CEZAR PEREIRA

RÉU: UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA.

SENTENÇA

LUCIANA TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA e **JULIO CEZAR PEREIRA** ajuizaram ação de obrigação de fazer contra a **UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA.**, todos já qualificados nos autos. Narraram, em suma, que Luciana é usuária do plano de saúde da ré, e portadora de neoplasia maligna de pulmão (CID 10 C34.9), do tipo neuroendócrino de pequenas células, atualmente em estágio clínico IV, sendo que o médico que lhe acompanha prescreveu o uso do fármaco ATEZOLIZUMABE 1200MG, a cada 21 dias. Todavia, a requerida indeferiu o pedido administrativo para fornecimento do fármaco, sob o fundamento de que se trata de tratamento *"off label"*. Teceu comentários acerca do fornecimento da medicação e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requereram, em sede de tutela antecipada, o fornecimento do fármaco e, ao final, a procedência da ação. Pediram a gratuidade judiciária. Juntaram documentos (evento 1).

Concedida a gratuidade judiciária e deferida a tutela antecipada (evento 3).

Citada (evento 8), a ré apresentou contestação e reconvenção. Em contestação, impugnou o valor atribuído à causa. No mérito, teceu comentários acerca da Lei 9.656/98, aduzindo que medicamentos *off label* não possuem cobertura pelo contrato firmado entre as partes, pois a cláusula 16 do contrato exclui expressamente a cobertura de tratamentos experimentais. Discorreu sobre a taxatividade do rol da ANS. Em reconvenção, em caso de procedência da ação, pugnou seja observada a coparticipação do usuário, no percentual de 30%, conforme previsto em contrato, pois não se trata de cláusula abusiva. Pugnou pela improcedência da ação e, em caso de procedência, pela procedência da reconvenção. Juntou documentos (evento 14).

A reconvenção foi recebida (evento 16).

Intimada, a parte autora apresentou réplica e contestação à reconvenção (evento 26).

Instadas as partes sobre a produção de provas, nada foi requerido (eventos 34 e 35).

É o relatório.

Decido.

Julgo o feito no estado em que se encontra, na forma do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, haja vista que se trata de matéria eminentemente de direito, não sendo necessária a produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

<u>Impugnação ao valor atribuído à causa</u>

No tocante à preliminar, saliento que comporta acolhimento o pedido formulado pela demandada. Isso porque, em se tratando de ação de obrigação de fazer, em que se busca o fornecimento de medicamento pela operadora do plano de saúde, inexiste proveito econômico imediato no pleito.

Outrossim, o direito pretendido concerne à saúde da autora, direito este cujo valor reputa-se inestimável, razão pela qual deve ser atribuído à causa o valor de alçada.

Nesse sentido, já se manifestou o TJRS:

> *APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. INTERESSE RECURSAL EXCLUSIVO DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO OBSERVÂNCIA A REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR DESERTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO LENALIDOMIDA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. 1. O RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR VERSA TÃO SOMENTE À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA, SENDO, PORTANTO, DE INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO. 2. OCORRE QUE, EMBORA DEVIDAMENTE INTIMADO, O DEMANDANTE/RECORRENTE NÃO COMPROVOU FAZER JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, TAMPOUCO EFETUOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. 3. DESTA FORMA, AUSENTE UM DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, NÃO DEVE SER CONHECIDO O RECURSO DO AUTOR POR DESERTO. 4.* ***DE OUTRO LADO, QUANTO AO APELO DA PARTE RÉ, DEVE SER ACOLHIDA A PRELIMINAR RECURSAL DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. TRATANDO-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM QUE É BUSCADO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, INEXISTE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO NO PLEITO. OUTROSSIM, O DIREITO PRETENDIDO TUTELAR CONCERNE À SAÚDE DO AUTOR, CUJO VALOR REPUTA-SE INESTIMÁVEL, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER ATRIBUÍDO À CAUSA O VALOR DE ALÇADA.*** *5. NO MÉRITO, INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO*

ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 6. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 7. RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO. 8. EM FACE DE TAIS CONSIDERAÇÕES, SENDO INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, ASSIM COMO QUE A PARTE AUTORA CUMPRIU TODAS AS CARÊNCIAS CONTRATUALMENTE EXIGIDAS, BEM COMO HAVENDO LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO POSTULADO NA EXORDIAL (LENALIDOMIDA), TEM-SE COMO DEVIDO O FORNECIMENTO DA ALUDIDA MEDICAÇÃO, SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE A TRATAMENTO DE PATOLOGIA INCONTROVERSAMENTE COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE (MIELOMA MÚLTIPLO), DESTARTE, AFIGURA-SE IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DO DEVER DE COBERTURA. 9. DESSE MODO, MERECE SER ACOLHIDO O APELO DA PARTE RÉ TÃO SOMENTE PARA ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, MANTIDO, QUANTO AO MAIS, O DECIDIDO NA R. SENTENÇA, INCLUSIVE QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA EM PARTE, UNICAMENTE PARA ACOLHER A PREFACIAL DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.(Apelação Cível, Nº 50024938920188210027, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 30-03-2022)(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEVER DE COBERTURA. TERAPIA OCUPACIONAL. MÉTODO NEUROEVOLUTIVO BOBATH. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DE ALÇADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CASO CONCRETO. ***1. O VALOR A SER ATRIBUÍDO À CAUSA DEVE REFLETIR O PROVEITO ECONÔMICO QUE SE BUSCA SATISFAZER, QUE, NO CASO, É INESTIMÁVEL. CASO EM QUE, EMBORA A PARTE AUTORA TENHA ACOSTADO ORÇAMENTOS NO INTUITO COMPROVAR O CUSTO DO TRATAMENTO PLEITEADO, É POSSÍVEL A ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE ALÇADA, HAJA VISTA QUE A OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO SE RESUME AO TRATAMENTO POR UM ANO, MAS ENQUANTO DURAR A NECESSIDADE, NOS TERMOS DO LAUDO MÉDICO.*** *2. A INAPLICABILIDADE DO CDC AOS PLANOS DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO NÃO IMPLICA INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ARTS. 421 E 422 DO CC). O ART. 423 DO CC DETERMINA QUE, NO CONTRATO DE ADESÃO, DEVE-SE ADOTAR A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. 3. O PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO, POIS CABE A ESTE DEFINIR QUAL É O MELHOR TRATAMENTO PARA O SEGURADO. ALÉM DISSO, O QUE IMPORTA É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO CONTRATO PARA A DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA, NÃO IMPORTANDO A FORMA COMO O TRATAMENTO SERÁ MINISTRADO. 4. HIPÓTESE EM QUE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO DEMONSTRAM QUE O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELOS PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHAM A PARTE AUTORA, PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN, SOB PENA DE OCORRÊNCIA DE GRAVES E IRREVERSÍVEIS DANOS À SAÚDE DA PACIENTE CASO O TRATAMENTO NÃO SEJA FORNECIDO. 5. VERBA HONORÁRIA QUE, NA ESPÉCIE, DEVE SER FIXADA DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, §8°, DO CPC, POR SER A CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001862-02.2019.8.21.1001, 5ª Câmara Cível, Desembargadora ISABEL DIAS ALMEIDA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 29/04/2021)(grifei)*

Deste modo, acolho a preliminar de impugnação ao valor atribuído à causa, determinando a retificação para o valor de alçada.

<u>Mérito</u>

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, em que pretende a parte autora que a ré seja compelida a fornecer o fármaco ATEZOLIZUMABE 1200mg, a cada 21 dias. Para tanto, aduziu que é portadora de neoplasia maligna de pulmão (CID 10 C34.9), do tipo neuroendócrino de pequenas células, atualmente em estágio clínico IV, sendo o tratamento indicado pelo médico assistente.

Inicialmente, cumpre consignar que os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação de consumo.

Aliás, sobre o tema em discussão o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 608, a qual dispõe que "*aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"*.

Com efeito, os planos de assistência à saúde devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo.

Destarte, estando os contratos submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, dentre outras, as seguintes regras: "*As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"* (art. 47 do CDC). E, considerar-se-ão abusivas, as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema (art. 51, incisos IV e XV e § 1º, incisos, I, II e III, do CDC).

Na hipótese dos autos, há prova inequívoca, consubstanciada no laudo médico, que comprova que a autora é portadora de neoplasia maligna de pulmão (CID 10 C34.9), do tipo neuroendócrino de pequenas células, atualmente em estágio clínico IV. De igual modo, restou demonstrada a necessidade de utilização do medicamento ATEZOLIZUMABE 1200MG, sendo que sua não utilização "*aumenta as chances de progressão da doença e morte"* (evento 1, LAUDO9).

A ré, contudo, negou na esfera administrativa o fornecimento do tratamento indicado, alegando que não está previsto no contrato ou no rol de procedimentos/tratamentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No entanto, é oportuno ressaltar que não cabe à demandada determinar o tipo de tratamento que será realizado pela parte autora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha, que no caso indicou o tratamento com o medicamento referido por ser o mais adequado às condições desta.

Ademais, cumpre destacar que predomina na jurisprudência o entendimento que o Rol de Procedimentos publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativo, não possuindo caráter taxativo.

Nesse sentido, é o posicionamento do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA ILÍCITA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. ***3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.***
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.991.304/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 19/5/2022.)(grifei)

De igual modo, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. MEDICAMENTO. REGORAFENIBE (STIVARGA). TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMA DE CÓLON. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, pois tal incumbência é do profissional que assiste o paciente, a quem compete avaliar os riscos e benefícios do tratamento e indicar a alternativa mais adequada (STJ, Resp nº 668.216-SP, j. 15.03.2007). ***O rol de procedimentos previsto nas normas da ANS não é taxativo, traduzindo somente um referencial de coberturas básicas para os planos de saúde.*** *Precedentes do TJRS. A ANS não veda o uso off label de um medicamento com registro na ANVISA e comercialização nacional, o que não se confunde com tratamento experimental a que alude o art. 10 da Lei 9.656/98. Precedente do STJ. No caso dos autos, o laudo médico e a prescrição atestam que a autora foi diagnosticada com "Adenocarcinoma de Cólon estágio IV (CID C18.9), necessitando fazer uso da substância Regorafenibe (nome comercial Stivarga), o qual está registrado na ANVISA sob o número 170560108. Cobertura devida. Sentença mantida no ponto. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCABIMENTO. Não havendo comprovação adequada dos danos morais alegadamente experimentados, afigura-se descabida a indenização pleiteada. Redimensionamento da sucumbência. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083936955, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 30-04-2020)(grifei)*

Além disso, a cobertura de tratamento oncológico necessário constitui exigência mínima dos planos de saúde, nos termos da Lei 9.656/98, possuindo previsão de cobertura expressa na Cláusula 13 do contrato (evento 1, CONTR8).

Por sua vez, é válido esclarecer que o uso de medicamento é considerado *off label* quando é utilizado para situações não previstas em sua bula, além de inexistir vedação pela ANS para uso *off label* de medicamento aprovado pela ANVISA, tendo em vista que não se confunde com tratamento experimental, não constando nas hipóteses de exclusão do artigo 10 da Lei nº. 9.656/98.

Assim, descabida e injustificada a negativa securitária sob a alegação de que o tratamento é experimental ou que o uso do medicamento é *off label*, pois o que importa é a existência de cobertura securitária para a patologia apresentada, e não o fármaco postulado ou a forma como o tratamento deverá ser ministrado, ainda mais em se tratando de doença grave, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO - USO OFF LABEL- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label).
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.940.157/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 21/2/2022.)(grifei)

RECONVENÇÃO

De outro quadrante, consigno que não há vedação legal específica quanto à possibilidade de exigência de participação do usuário nas despesas médico-hospitalares, desde que proporcional ao custo do procedimento a ser feito e valor da prestação do plano de saúde, conforme dispõe o artigo 16, VIII da Lei 9.656/98, *in verbis:*

"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;".

Além disso, a Cláusula 38, inciso II, alínea 'e', do Contrato de Assistência à Saúde (evento 1, CONTR8) prevê de forma clara a cobrança de coparticipação do segurado do plano de saúde, não restando evidenciada, dessa forma, qualquer nulidade contratual ou mesmo eventual violação ao dever de informação ao consumidor.

Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se afigura ilícita a cláusula contratual que prevê a coparticipação do beneficiário, ainda que prevista em percentual sobre o custo do tratamento, desde que contratada de forma clara e expressa. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADA APOSENTADA. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL. NÃO OCORRÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO INDIRETO. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O STJ firmou o entendimento de que o direito à manutenção no plano de saúde empresarial de ex-empregado, demitido ou aposentado, está condicionado à existência de contribuição do beneficiário para o prêmio mensal, não se aplicando em casos de coparticipação.
2. "O plano de saúde custeado pelo empregador não ostenta natureza salarial, ainda que indireta" (AgInt no Resp n. 1.633.888/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017).
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp n. 1.867.404/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 23/9/2021.)

Da mesma forma, são os arestos do TJRS:

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO OFF LABEL. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. COBERTURA DEVIDA. COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA QUANTO AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO. DANOS MORAIS DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA SEM JUSTA CAUSA. 1. OS PLANOS OU SEGUROS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ENQUANTO RELAÇÃO DE CONSUMO ATINENTE AO MERCADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ISTO É O QUE SE EXTRAI DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 35 DA LEI 9.656/98. SÚMULA N. 608 DO STJ. 2. APLICÁVEIS AO CASO EM EXAME AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PREVISTAS NO PLANO-REFERÊNCIA DE QUE TRATA OS ARTIGOS 10 E 12 DA LEGISLAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE. 3. A DEMANDADA NÃO TEM O DIREITO DE DETERMINAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ REALIZADO PELA PARTE AUTORA, DECISÃO QUE CABE AO MÉDICO QUE O ACOMPANHA E, NO CASO, INDICOU O TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO REFERIDO POR SER O MAIS ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES DO DEMANDANTE. 4. INEXISTE VEDAÇÃO PELA ANS PARA USO OFF LABEL DE MEDICAMENTO APROVADO PELA ANVISA, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM TRATAMENTO EXPERIMENTAL, NÃO CONSTANDO NAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DO ARTIGO 10 DA LEI Nº. 9.656/98. 5. ASSIM, DESCABIDA E INJUSTIFICADA A NEGATIVA SECURITÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO É EXPERIMENTAL OU QUE O USO DO MEDICAMENTO É OFF LABEL, POIS O QUE IMPORTA PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA A PATOLOGIA APRESENTADA, E NÃO O FÁRMACO POSTULADO OU A FORMA COMO O TRATAMENTO DEVERÁ SER MINISTRADO, AINDA MAIS EM SE TRATANDO DE DOENÇA GRAVE COMO O CÂNCER. 6. O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO, SEM RAZÃO JURÍDICA PLAUSÍVEL, OU MESMO O ATENDIMENTO DO PACTO DE FORMA NEGLIGENTE, SEQUER ATENTANDO PARA A GARANTIA DADA E O BEM A SER PRESERVADO, IMPORTA NO DEVER DE REPARAR O MAL CAUSADO. 7. A DEMANDADA DEVE RESSARCIR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS, NA FORMA DO ART. 186 DO NOVO CÓDIGO CIVIL, CUJA INCIDÊNCIA DECORRE DA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA, A QUAL SE CONFIGUROU NO CASO EM TELA. ***8. NOS TERMOS DO ATUAL POSICIONAMENTO JURÍDICO DO STJ, A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COPARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO SE AFIGURA ILÍCITA, AINDA QUE PREVISTA EM PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DO TRATAMENTO, DESDE QUE CONTRATADA DE FORMA CLARA E EXPRESSA. 9. RESSALTA-SE QUE O CONTRATO É CLARO E EXPRESSO AO PREVER A COPARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, ESPECIFICANDO OS PERCENTUAIS SOBRE OS CUSTOS DAS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS, INEXISTINDO AFRONTA AO DEVER DE INFORMAR PREVISTO NO ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 10. ASSIM, INEXISTE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA PELA RÉ DE COPARTICIPAÇÃO SOBRE O VALOR DO TRATAMENTO, PORQUANTO A MEDIDA VISA UMA DIMINUIÇÃO DO CUSTO DO SEGURO OU PLANO DE SAÚDE, DE MODO QUE O AFASTAMENTO DA CLÁUSULA IMPLICARIA EM MODIFICAÇÃO DO CONTRATO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.*** *NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. (Apelação Cível, Nº 50127529320208210021, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 30-03-2022)(grifei)*

Portanto, inexiste nulidade da cláusula contratual que prevê a coparticipação do beneficiário, ainda que prevista em percentual sobre o tratamento, uma vez que contratada de forma clara e expressa.

Ante o exposto, confirmo a liminar de evento 3, e **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **LUCIANA TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA** e **JULIO CEZAR PEREIRA** contra a **UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA,** para o fim de **CONDENAR** a parte ré à obrigação de fazer consistente no fornecimento à parte autora do medicamento ATEZOLIZUMABE 1200MG, conforme prescrição médica, observada a coparticipação da parte segurada.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, e honorários ao patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% do valor da causa, conforme dispõe o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho desenvolvido, a natureza da causa e o tempo de tramitação do feito.

Outrossim, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado em reconvenção pela **UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA** contra **LUCIANA TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA** e **JULIO CEZAR PEREIRA,** para **DETERMINAR** a incidência de coparticipação no tratamento postulado pela autora, nos termos previstos em contrato (30%).

Condeno a reconvinda ao pagamento das custas processuais, e honorários ao patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% do valor da causa, conforme dispõe o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho desenvolvido, a natureza da causa e o tempo de tramitação do feito. Suspensa a exigibilidade em razão da AJG.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Em caso de apelação, em virtude do novo regramento do CPC/2015, em que não é realizado juízo de admissibilidade pelo Juízo de 1.º Grau, intime-se o apelado para contrarrazões no prazo legal, remetendo-se à instância superior, com as nossas homenagens.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **VANCARLO ANDRE ANACLETO, Juiz de Direito**, em 25/5/2022, às 18:47:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10019572625v14** e o código CRC **b954fba8**.